

a3_cda_hub 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:09:28

测试时间：2026-05-08 20:09:28

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
1) 启用工具运行；2) 禁用工具运行；3) 指标对照；4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1897 markers=13

禁用工具 success=True chars=1179 markers=16

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险照护联动:tool_风险照护联动：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

GP协作专业答复报告

患者姓名：陈萍忠

日期：2026年4月

一、GP确认意见

经审阅最新临床信息，确认患者陈萍忠目前存在明确的精神行为症状（BPSD），主要表现为因阿尔茨海默病性痴呆所致的**拒绝配合康复训练及认知干预活动**，虽无攻击性行为，但已显著影响非药物干预效果及整体照护进程。结合其头部外伤恢复期、心血管基础疾病（起搏器植入、血压偏高）及家属显著的长期照护焦虑，**符合精神科专科会诊指征**。

GP支持护理团队提出的“加强精神科干预”建议，并确认当前病情需要多学科协同管理，尤其需关注行为症状对功能维持及家庭照护可持续性的负面影响。

二、精神科会诊决策

建议**立即启动精神科紧急会诊**，具体决策如下：

1. **会诊目的**：

- 全面评估BPSD类型、频率、诱因及对日常生活的影响程度；
- 审查当前精神类药物使用（如奥氮平1.0mg、劳拉西泮2.0mg晚间服用）的合理性、剂量安全性及与心血管药物的相互作用；
- 制定以非药物干预为核心的个体化行为管理方案，优先利用患者既往“喜爱跳舞”的兴趣点，设计低结构化、高愉悦感的活动形式；
- 评估家属照护压力水平，提供心理教育及应对策略。

2. **特别注意事项**：

- 患者有心脏起搏器植入史且历史数据显示心率持续偏低（最低60次/分），任何拟新增或调整的精神科药物（尤其是抗精神病药）必须严格评估QT间期延长及心动过缓风险；
- 避免过度依赖镇静类药物，优先采用环境调整、节奏性音乐活动、陪伴式引导等非药物策略。

三、照护目标更新

在原有跌倒防护、规律服药、皮肤完整性维护等目标基础上，**新增及调整以下短期目标（1-2周内）**：

1. **行为管理目标**：

- 72小时内完成精神科初步评估并制定行为干预计划；
- 将认知干预活动调整为“微时长、高频次、兴趣导向”模式（如每日2次、每次10分钟的轻柔舞蹈律动），以提升参与意愿；
- 建立BPSD行为日志，记录拒绝行为发生时间、情境、前驱因素及缓解措施。

2. **家属支持目标**：

- 安排社工或心理咨询师于3日内与家属进行首次照护指导会谈，内容包括：BPSD知识普及、沟通技巧训练、自我情绪调节方法；
- 提供书面《失智照护应急指南》，涵盖行为应对、资源链接及喘息服务信息。

3. **医疗监测目标**：

- 继续落实日间多时段生命体征监测（尤其心率、血压），确保精神科干预不加重循环负担；
- 推进凝血功能检查以排查反复皮肤淤青的潜在病因（结合他汀类用药史）。

四、多方协同分工

为确保

【禁用工具输出摘录】

GP协作专业答复报告

患者姓名：陈萍忠

****报告日期****：近期

一、GP确认意见

本人确认患者陈萍忠当前临床状况符合以下特征：

- 确诊阿尔茨海默病性痴呆，处于疾病进展期；
- 存在显著的行为和心理症状（BPSD），表现为拒绝配合康复训练，影响治疗依从性与照护安全；
- 合并多种慢性疾病（高血压、血脂异常）、心脏起搏器植入史及近期头部外伤恢复期，属高跌倒风险人群；
- 家属呈现明显长期照护焦虑，需系统性支持。

基于上述情况，本人认可护理团队提出的综合照护重点（跌倒防护、规律服药）及初步干预尝试（结合跳舞喜好进行认知刺激）。鉴于BPSD症状持续且影响整体照护效能，****支持立即启动精神科专科会诊****，以优化行为管理策略。

二、精神科会诊决策建议

建议精神科团队重点评估以下方面：

1. BPSD的具体表现类型（如激越、淡漠、抗拒）及其对日常功能的影响程度；
2. 非药物干预方案的可行性优化（例如：调整跳舞干预的频率、形式、引导方式以提升接受度）；
3. 是否存在使用抗精神病药物或其他精神类药物的临床指征，并权衡获益与风险（尤其考虑起搏器及高龄因素）；
4. 家属焦虑的心理社会成因，是否需联合心理支持或照护技能培训。

三、照护目标更新

在原有基础照护目标基础上，更新/新增以下短期目标（2-4周）：

1. ****行为目标****：减少因BPSD导致的康复拒绝行为频次 $\geq 30\%$ ；
2. ****认知干预目标****：通过个性化调整（如音乐律动、回忆疗法结合舞蹈元素），提升每日认知活动参与时长至 ≥ 15 分钟；
3. ****家属支持目标****：通过至少1次结构化照护指导，帮助家属掌握2-3项应对BPSD的实用技巧，初步缓解焦虑情绪；
4. ****安全目标****：维持零跌倒事件，确保降压及调脂药物按时服用率 $\geq 95\%$ 。

四、多方协同照护分工建议

- ****全科医生（GP）****：统筹医疗管理，监测血压、血脂控制情况，评估药物相互作用风险，协调各专科意见整合；
- ****精神科团队****：主导BPSD评估与干预方案制定，定期反馈疗效，指导非药物策略实施；
- ****护理团队****：严格执行跌倒预防措施，监督规律服药，记录BPSD行为日志，灵活

执行优化后的认知干预活动；

- **社工/心理支持人员**：为家属提供照护压力疏导、沟通技巧培训及社区资源链接；
- **康复治疗师**：在精神科指导下，调整康复介入方式，避免强制性训练，强调愉悦性与参与感。

****注****：本报告基于当前提供之实时信息生成，未引用历史图谱数据。后续建议根据精神科会诊结果及家属反馈动态调整照护计划。